

Lúpus eritematoso sistêmico · flares e nefrite

LES é doença multissistêmica: combine clínica + autoanticorpos. Em prova, nefrite lúpica, serosite, citopenias e acometimento de SNC são os flares que mudam conduta.

Anticorpos

Lembre - Anticorpos

FAN é sensível, pouco específico. Anti-dsDNA e anti-Sm são mais específicos; anti-dsDNA correlaciona com atividade e nefrite. Antifosfolípides: trombose/aborto — pense SAF secundária.

Ramifique: manutenção com HCQ versus imunossupressão/internação no órgão-alvo grave.



Manejo high-yield

- Hidroxicloroquina para quase todos (salvo contraindicação) — reduz flares e trombose
- Nefrite: HA + proteinúria + sedimento ativo !' corticoterapia + MMF/ciclofosfamida conforme classe
- Evitar gestação em doença ativa; planejar com HCQ e times multidisciplinares
- Vacinas inativadas OK; atenção a imunossupressão e infecções oportunistas

Achados clássicos

Sistema | Manifestação de prova

Pele/mucosa | Malar, discoide, úlceras orais, fotossensibilidade

Rim | Proteinúria, cilindros, !'creatinina

Hematológico | Anemia hemolítica, leucopenia, trombocitopenia

Sorologia | FAN, anti-dsDNA, consumo de complemento

Armadilha de prova

Atenção - Armadilha de prova

Não atribua febre só a 'atividade de LES' sem excluir infecção — imunossuprimidos infectam. Em dor torácica, pense pericardite/serosite, mas também TEP se antifosfolípide.